COMPRENDRE • UE B3 / S1

Prévenir le risque infectieux

Hygiène • précautions standard, AES/AEV et antisepsie • source Moodle

Comprendre la transmission

Une infection associée aux soins survient au cours ou au décours d'une prise en charge, sans être présente ni en incubation au début. Pour qu'une transmission conduise à une infection, plusieurs éléments s'articulent : micro-organisme/réservoir, mode de transmission, porte d'entrée, hôte et facteurs favorisants.

Modes de transmission

Contact direct (dont peau à peau) ou indirect (mains, matériel, surfaces) ; gouttelettes ; transmission par l'air selon l'agent et la situation. Les mains et l'environnement proche jouent un rôle central dans la transmission croisée.

Raisonner le risque

Repérer le réservoir, l'exposition et les mesures de prévention. Les précautions standard s'appliquent à tout patient, tout soin, tout lieu, sans attendre un statut infectieux connu.

Mettre la chaîne en lien avec le soin

Les infections urinaires et du site opératoire, les infections respiratoires ou liées à des dispositifs peuvent s'inscrire dans des chaînes de transmission différentes. Repérer le geste, le réservoir possible et les voies de transfert aide à choisir la précaution. Le risque s'évalue dans le contexte ; il ne se déduit pas d'une apparence.

Étape de la chaîne	Exemple de question clinique
Réservoir / agent	Quel agent ou réservoir est plausible ici ?
Transmission	Contact, gouttelettes, air, matériel ou mains ?
Porte d'entrée / hôte	Quelle exposition, quelle vulnérabilité ?

Élément	À repérer
Réservoir	Qui/quoi porte l'agent ?
Transmission	Comment atteint-il la personne ?
Porte d'entrée / hôte	Quelle exposition et quelles vulnérabilités ?

COMPRENDRE • UE B3 / S1

Prévenir le risque infectieux

Hygiène • précautions standard, AES/AEV et antisepsie • source Moodle

Précautions standard : protection ajustée

Hygiène des mains, équipements de protection individuelle adaptés au risque, prévention des accidents d'exposition, gestion sûre du matériel et de l'environnement, hygiène respiratoire et maîtrise des excreta/linge/déchets s'intègrent au même raisonnement.

Gants et autres EPI

Les gants ne remplacent pas l'hygiène des mains et ne sont pas systématiques sur peau saine. Les porter selon le risque de contact avec sang/liquides biologiques, peau lésée ou muqueuse, et lors d'un soin exposant. Tablier, masque et protection oculaire dépendent notamment du risque de souillure ou projection et des consignes applicables.

Avant le soin

Préparer l'environnement et le matériel, dégager les avant-bras, retirer bijoux, garder les ongles courts sans vernis/faux ongles, vérifier la peau des mains et organiser l'élimination des objets piquants/coupants au plus près du soin.

Standard = socle commun

Les précautions standard concernent chaque personne, qu'un risque soit connu ou non. Elles structurent l'hygiène des mains, les EPI, la prévention des AES, la gestion des surfaces et du matériel, ainsi que l'hygiène respiratoire. Des précautions complémentaires peuvent s'ajouter selon la situation et le protocole.

Prévision du risque	Protection à ajuster
Contact peau saine uniquement	Hygiène des mains ; gants non systématiques.
Risque de liquide biologique	Gants selon le geste ; hygiène des mains avant/après.
Projection / souillure	Tablier et protection visage selon le risque et le protocole.

COMPRENDRE • UE B3 / S1

Prévenir le risque infectieux

Hygiène • précautions standard, AES/AEV et antisepsie • source Moodle

Hygiène des mains

Cinq indications : avant contact patient ; avant geste aseptique ; après risque d'exposition à un liquide biologique ; après contact patient ; après contact avec son environnement. La friction hydro-alcoolique est la technique de référence si les mains ne sont pas visiblement souillées. Eau + savon si souillure visible ou besoin de détersion ; bien rincer/sécher puis appliquer l'hygiène requise.

Choisir en fonction du risque

Les gants ne sont pas portés « par habitude » : préciser le geste et l'exposition prévisible. Ajouter tablier/protection selon risque de projection ou de mouillage. Retirer les EPI sans contaminer peau, tenue ou environnement, puis pratiquer l'hygiène des mains.

Antisepsie et asepsie

Asepsie : prévenir l'introduction de micro-organismes pendant un soin. Antisepsie : réduire ou éliminer les micro-organismes sur tissus vivants à l'aide d'un antiseptique adapté. Respecter indication, produit, zone, temps de contact et procédure du terrain ; les gestes sont entraînés en TP.

Les 5 moments guident le geste

L'hygiène des mains s'inscrit dans les transitions entre environnement, patient, site aseptique et exposition aux liquides biologiques. Avant le contact et le geste aseptique, elle protège la personne ; après exposition, contact ou environnement, elle évite de disséminer. Les bijoux, manches longues et ongles artificiels nuisent à une friction correcte.

Mains visiblement souillées ?	Conduite
Non	Friction hydro-alcoolique jusqu'au séchage complet.
Oui / détersion nécessaire	Eau + savon, rinçage et séchage ; refaire l'hygiène requise.
Quel que soit le choix	Retirer bijoux, avant-bras dégagés, ongles courts.

Moment	Hygiène des mains
1	Avant le contact patient
2	Avant geste aseptique
3	Après risque biologique
4–5	Après contact patient / environnement

COMPRENDRE • UE B3 / S1

Prévenir le risque infectieux

Hygiène • précautions standard, AES/AEV et antisepsie • source Moodle

AES/AEV : agir sans délai

En cas de piqûre/coupure ou peau lésée : ne pas faire saigner ; nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ; rincer puis réaliser l'antisepsie conformément au protocole AES. En cas de projection sur une muqueuse : rincer immédiatement et abondamment à l'eau ou au sérum physiologique.

Après les gestes immédiats

Prévenir sans délai selon l'organisation du terrain et solliciter une évaluation médicale rapide. Déclaration et suivi selon protocole de l'établissement. Les délais, bilans et traitements post-exposition relèvent des recommandations et procédures actualisées.

En stage

Identifier le protocole AES du service, le lieu de prise en charge immédiate et le circuit de déclaration avant le premier soin à risque. Signaler un incident sans attendre la fin du poste.

Conduite AES : chaque minute compte

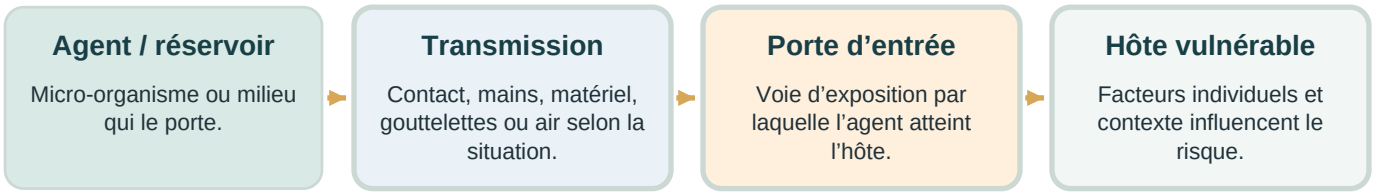
Après les gestes locaux, ne pas rester seul : signaler immédiatement, obtenir un avis médical rapide et suivre le circuit de déclaration et de surveillance du terrain. Le patient source peut être évalué selon le protocole. Ne pas improviser de délai, bilan ou traitement : ces décisions suivent les recommandations actualisées.

Exposition	Première conduite
Piqûre / coupure / peau lésée	Ne pas faire saigner → eau + savon → rincer → antisepsie selon protocole.
Projection muqueuse	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau ou au sérum physiologique.
Ensuite	Alerte immédiate → évaluation médicale rapide → déclaration/suivi.

Source Moodle : Hygiène • précautions standard, AES/AEV et antisepsie • UE B3 / S1. Repères de pratique à articuler aux protocoles de l'établissement et à l'encadrement de stage.

Prévenir le risque infectieux

Schéma de synthèse détaillé • construit à partir du cours associé



Légende et repères d’application

1. Une infection résulte d’une chaîne; interrompre une étape réduit le risque.
2. Précautions standard : tout patient, tout soin, tout lieu.
3. Hygiène des mains, matériel, environnement et gestes adaptés agissent sur des maillons différents.
4. Adapter les précautions au geste, à l’agent suspecté et au protocole.

À retenir

Réservoir → transmission → porte d’entrée → hôte. Rechercher où agir, sans attendre un statut connu.

Synthèse visuelle originale, fidèle aux notions du cours source. Utiliser les prescriptions et protocoles applicables.